LAUDO PSICOLÓGICO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Autora: Thuanne de Castro Martins Lima CRP: 01/24215
Assunto: Solicitação de Avaliação Neuropsicológica.

Nome: **Rafael Gonçalves de Paulo.**
Idade: **24 anos.**
Data de Nascimento: **24/08/1998.**
Datas da avaliação: **18/04/2023** à **23/05/2023**.
Solicitação: **Avaliação Neuropsicológica solicitada pelo Médico Psiquiatra.**

1. DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Rafael foi encaminhado para a avaliação neuropsicológica pelo Médico Psiquiatra, devido ao quadro de queixas de ansiedade, baixa higiene, apatia, dificuldade para dormir, procrastinação, transtornos sensoriais e dificuldade de interação.

Levando em consideração a demanda descrita, objetivou-se avaliar as funções executivas e neurocognitivas do paciente, assim como a personalidade, a fim de melhor compreender o seu perfil.

A avaliação foi composta por uma sessão de entrevista (anamnese) com o paciente, quatro sessões de aplicação de instrumentos neuropsicológicos e psicológicos e uma sessão devolutiva.

Rafael foi submetido à avaliação neuropsicológica a fim de avaliar seu quadro cognitivo e psicológico.

1.1 HISTÓRICO COLHIDO NA ANAMNESE

Rafael tem 24 anos e apresenta sensibilidade a sons, texturas e cheiros, ansiedade, pouca higiene, dificuldade em fazer planos a longo prazo, apatia, falta de energia, dificuldade na dicção, seletividade alimentar, assiste a filmes e vídeos de forma repetitiva, gosta de seguir rotina, procrastina atividades, dificuldade de gerenciamento de tempo, desorganização, dificuldade para dormir, agitação, não faz contato visual, tem dificuldade na interação social e tem interesses incomuns.

Socialização e histórico da infância: Conforme coleta de informações, por meio de um questionário sobre a infância do paciente, a mãe de Rafael relata que ele tinha sensibilidade a sons, texturas e cheiros, caminhava na ponta dos pés, tinha apego exagerado a determinados objetos, não gostava de sair da rotina, ficava tenso em situações sociais, tinha dificuldade em fazer amigos, ficava tenso em situações sociais e preferia ficar sozinho do que com outras pessoas.

Histórico clinico:

Rafael faz acompanhamento com Psiquiatra e faz uso dos medicamentos: Sertralina e Lítio.

Os seguintes instrumentos foram aplicados para avaliar as funções executivas, cognitivas e do neurodesenvolvimento:

- **Teste de Aprendizagem Auditivo- Verbal de Rey** (RAVLT)
- **Escala de Inteligência Weschler para Adultos** (WAIS-III)
- **Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção 2** (BPA 2)
- **Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade** (ETDAH-AD)
- **Escala dos Pilares de Resiliência** (EPR)

- **Escala Baptista de Depressão** (EBADEP A)
- **Escala de Responsividade Social** (SRS 2)

2. OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

Rafael apresentou dificuldade em desenvolver atividades dos testes que exigiam a comunicação direta, evitava fazer o contato visual com a examinadora, dificuldade de manter atenção e concentração (principalmente em testes longos e repetitivos) e evidenciou dificuldade para expressar suas ideias durante os testes de fluência verbal.

O paciente se mostrou detalhista, perfeccionista e metódico.

3. RESULTADO DOS INSTRUMENTOS

3.1 Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey – RAVLT

O objetivo do teste e avaliação RAVLT é avaliar a memória declarativa episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência e de retenção de informações e memória de reconhecimento.

Na **Memória de Curto Prazo Imediata**, no **Plano Auditivo Verbal** (retenção simples de pequenas quantidades de informação repetidas imediatamente após um pequeno intervalo, em segundos) o paciente apresentou desempenho “Médio Inferior”, quando comparado a população de mesma faixa etária. Aqui, Rafael, apresenta dificuldade em manter, temporariamente, o conteúdo verbal apresentado pela examinadora. Essa memória é responsável por reter a informação logo que é recebida. Fica evidente que o paciente tem defasagem da memória imediata verbal.

Na **Memória de Curto prazo,** no **Plano Episódica Verbal,** apresentou desempenho “Médio”, mostrando boa capacidade de se lembrar das palavras da lista A após ser exposta a uma outra lista de interferência (lista B). Isso significa que o paciente tem preservação da memória/interferência proativa (A interferência proativa ocorre

quando você está tentando se lembrar de algo que memorizou há relativamente pouco tempo e uma memória passada e separada o atrapalha nesse processo).

Na **Memória Episódica Verbal** ou **Memória de Reconhecimento** o paciente apresentou desempenho "Médio", significa dizer que, Rafael tem facilidade na capacidade de organização das respostas e preservação da memória de curto prazo (a memória de reconhecimento ou memória de curta duração refere-se à informação que é enviada para a memória de curto prazo, na qual essa informação seria analisada e codificada. Essa aquisição depende da atenção, da percepção e da interpretação/compreensão da informação a ser aprendida).

Na **Medida Global de Aprendizagem Auditivo-Verbal,** o paciente apresenta desempenho "Médio", isso nos mostra que o paciente tem uma boa capacidade para aprender quando comparado a população da mesma faixa etária.

3.2 Escala Wechsler de Inteligência para Adultos – WAIS-III

Escores ponderados obtidos na escala WAIS- III

		Subtestes WAIS-III		
		Escore ponderado	Média	Máxima
Escala Wechsler de Inteligência para adultos (WAIS-III)	**Escala Verbal**			
	Aritmética	7	≥10	19
	Compreensão	10	≥10	19
	Dígitos	9	≥10	19
	Semelhanças	11	≥10	19
	Sequência de Números – Letras	9	≥10	19
	Vocabulário	8	≥10	19
	Informação	10	≥10	19
	Escala de Execução			
	Códigos	12	≥10	19
	Completar Figuras	9	≥10	19
	Cubos	12	≥10	19
	Raciocínio Matricial	10	≥10	19

ESCALA VERBAL

Avalia a capacidade em lidar com símbolos abstratos, compreensão verbal, fluência verbal e informação de conteúdo (educação formal e as estimulações ambientais). Também proporciona informações sobre processamento da linguagem, raciocínio abstrato, atenção, aprendizagem verbal e memória. Segue abaixo o que cada subteste avalia:

Informação: Determina a quantidade de informação que a pessoa adquire do ambiente a sua volta e indica sua capacidade intelectual. Avalia memória de evocação, capacidade de compreensão, capacidade de pensamento associativo (raciocínio abstrato) e nível de interesse pela leitura. O êxito nesse teste depende da experiência diária e/ou da escolaridade.

Semelhanças: Este subteste está relacionado com a inteligência geral do indivíduo e sua capacidade de trabalhar com o pensamento associativo e com a abstração. O êxito neste teste depende do contato com a realidade, dos níveis das informações recebidas do ambiente e do seu desenvolvimento da linguagem e fluência verbal.

Aritmética: Esta prova avalia a agilidade mental (memória operante), organização sequencial e a capacidade de atenção concentrada. O êxito nesse teste depende da habilidade em lidar com conceitos numéricos abstratos, memória auditiva, memória de curto prazo, raciocínio lógico e abstração.

Vocabulário: Essa prova abrange a avaliação da capacidade de aprendizagem e da conceituação verbal, assim como de sua reserva de informações, conhecimento semântico, da riqueza de suas idéias, da qualidade de sua linguagem e do nível de pensamento abstrato. Esse teste reflete o nível de escolaridade e do ambiente em que o sujeito está inserido.

Compreensão: Essa prova explora a capacidade de compreensão de situações comportamentais de natureza social. O êxito neste teste é influenciado pela capacidade de verbalização, do raciocínio abstrato verbal, capacidade de senso comum, juízo crítico social e moral. Além disso, avaliar a adaptação dos domínios adquiridos nas atividades de vida diária e prática, conhecimento de normas socioculturais, capacidade para avaliar a experiência passada, memória e atenção, compreensão verbal; e reflete, geralmente estabilidade e equilíbrio emocional.

Dígitos: Avalia a capacidade de memória auditiva imediata, capacidade de agrupamento de operações, atenção focal, agilidade mental e concentração.

Sequência de Números-Letras: avalia a memória operacional, memória imediata, capacidade de planejamento e capacidade de fazer operações mentais.

ESCALA DE EXECUÇÃO

Avalia a medida da organização perceptual, processamento visual, habilidade viso motora, capacidade de planejamento, aprendizagem não verbal, habilidades para pensar e manipular estímulos visuais com rapidez de velocidade. Nessa escala, todas as avaliações das provas utilizam tempo pré-determinado para a tarefa. Segue os subtestes presentes nesta escala:

Completar Figuras: essa prova requer a identificação visual de objetos, formas e utensílios familiares (percepção de detalhes comuns), junto com a capacidade para identificar e diferenciar as características essenciais das não-essenciais. A atenção e concentração são fatores importantes para o êxito nesse teste.

Cubos: Essa prova avalia a coordenação visomotora, além da capacidade de percepção, de organização espacial, de planejamento, capacidade potencial de inteligência em nível não-verbal e análise, síntese e reprodução de desenhos abstratos.

Raciocínio Matricial: Este subteste avalia o processamento de informações visuais, raciocínio abstrato, raciocínio analógico e raciocínio em série.

Código: Essa prova avalia a coordenação visomotora, além de exigir capacidade de compreender um material novo apresentado em um contexto associativo. O êxito nessa prova depende da atenção e concentração e da rapidez e precisão na execução do teste, além de memória de curto prazo e flexibilidade mental.

Análise Qualitativa Do Quociente Intelectual E Índices Fatoriais Da Bateria WAIS-III

Tabela 2: Índices Fatoriais obtidos na escala WAIS – III

Escalas	Soma dos Pontos Ponderados	QI – Índices Fatoriais	Interpretação
Índice de Compreensão Verbal **(ICV)**	29	**98**	**Média**
Índice de Organização Perceptual **(IOP)**	31	**102**	**Média**
Índice de Memória Operacional **(IMO)**	25	**113**	**Média Superior**
Índice de Velocidade de Processamento **(IVP)**	13	**80**	**Média Inferior**
Índice Verbal	64	**103**	**Média**
Índice de Execução	43	**90**	**Média**
QI total	107	**98**	**Média**

ÍNDICE DE COMPREENSÃO VERBAL (I.C.V.): Avalia a inteligência verbal e a capacidade reflexiva intelectual. É sensível a interferência de fatores emocionais e de estimulação socioafetiva e socioambiental.

ÍNDICE DE ORGANIZAÇÃO PERCEPTUAL (I.O.P.): Avalia a inteligência não verbal e o uso de estímulos viso espaciais na resolução de novos problemas. É sensível a fatores neuromaturativos.

ÍNDICE DE MEMÓRIA OPERACIONAL (I.M.O.): Avalia a concentração e memória imediata e apresenta grande correlação com as habilidades de matemática e atenção. É sensível à detecção de transtorno de déficit de atenção, a transtornos neurológicos, à imaturidade psiconeurológica e a fatores emocionais, associados, sobretudo, à interferência de ansiedade e/ou depressão nos processos cognitivos.

ÍNDICE DE VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO (I.V.P.): Avalia a capacidade de planejar, organizar e desenvolver estratégias e reflete a velocidade mental e psicomotora. É sensível a fatores neurológicos, à maturação motora, a fatores atencionais e a fatores emocionais, associados, sobretudo, à depressão.

3.3 Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção 2 – BPA 2

A Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção-2 (BPA-2) tem por objetivo mensurar a capacidade geral de atenção, bem como realizar uma avaliação de tipos de atenção específicos, quais sejam: Atenção Alternada (AA), Atenção Concentrada (AC) e Atenção Dividida (AD).

A Atenção Alternada indica a capacidade que um indivíduo tem em focalizar sua atenção ora em um estímulo, ora em outro. A Atenção Concentrada é definida como a capacidade de um indivíduo selecionar apenas uma fonte de informação em

detrimento de outros estímulos, ao passo que a Atenção Dividida se refere à capacidade de uma pessoa buscar dois ou mais estímulos simultaneamente.

Atenção	Pontos	Percentil	Classificação
Atenção Concentrada - AC	**120**	**99**	**Superior**
Atenção Dividida - AD	**112**	**90**	**Superior**
Atenção Alternada - AA	**116**	**80**	**Superior**
Atenção Geral – AG	**348**	**99**	**Superior**

ANALISE DO TESTE:

Atenção Concentrada (AC) – Média Superior: Rafael Gonçalves de Paulo dispõe de atenção concentrada bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para selecionar uma única fonte de informação diante de vários estímulos distratores em um tempo predeterminado.

Atenção Dividida (AD) – Superior: Esse resultado indica que Rafael Gonçalves de Paulo dispõe de atenção dividida bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para procurar dois ou mais estímulos simultaneamente em um tempo predeterminado, e com vários distratores ao redor.

Atenção Alternada (AA) – Superior: Rafael Gonçalves de Paulo dispõe de atenção alternada bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para focar sua atenção e selecionar ora um estímulo, ora outro, por um determinado período de tempo e diante de vários estímulos distratores.

Atenção Geral (AG) – Superior: Rafael Gonçalves de Paulo foi submetido à BPA-2 e obteve uma pontuação bruta total 348 pontos, que corresponde ao percentil 99. Esse resultado sugere que Rafael Gonçalves de Paulo apresenta uma capacidade atencional geral bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa.

3.4 Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - ETDAH-AD

A escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade auxilia no processo diagnóstico do TDAH, com a possibilidade de distinguir a apresentação do transtorno, a intensidade e o nível de prejuízo existente (leve, moderado ou grave).

Quadro de Resultados

Fator	Resultado Bruto	Percentil	Classificação
Desatenção (D)	66	95	**Superior**
Impulsividade (I)	49	75	**Média Superior**
Aspectos Emocionais (AE)	7	70	**Média Superior**
Auto reg. Att., da Mot. e Ação (AAMA)	20	60	**Média**
Hiperatividade (H)	18	80	**Média Superior**

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Desatenção: Superior. Resultado compatível com prejuízos importantes e sérias dificuldades, sendo considerado de nível grave. Altos escores aqui, refletem prejuízos consideráveis em funções executivas, tais como permanecer alerta para cumprir as exigências de uma situação e de se engajar em uma tarefa, dificuldades para realizar atividades que exijam atenção, bem como persistir no esforço com a motivação necessária, principalmente em projetos de longo prazo.

Impulsividade: Média Superior. Escores altos aqui, apresentam necessidade em seguir um cronograma preestabelecido para atividades do dia a dia. Além de apresentar comportamentos mais desorganizados.

Aspectos Emocionais: Média Superior. Resultado compatível com dificuldades emocionais, relacionadas com a instabilidade de humor e irritabilidade.

Autoregulação da Atenção, da Motivação e da Ação: Média. Escores médios podem mostrar boa resolução de problemas, e capacidade adequada na regulação da motivação e persistência de seus objetivos.

Hiperatividade: Média Superior. Resultado compatível com prejuízos importantes e sérias dificuldades, sendo considerado de nível moderado. Os resultados refletem um ritmo acelerado que pode comprometer a qualidade do trabalho, distração e instabilidade comportamental, como alterações na qualidade do sono e na memória.

3.5 Escala Baptista de Depressão Versão Adulto – EBADEP - A.

A Escala Baptista de Depressão (EBADEP-A) é um instrumento que tem como objetivo avaliar a intensidade da depressão em adolescentes e adultos. É um instrumento que contém 45 itens com 26 descritores de sintomatologia depressiva. Os sintomas são agrupados em sete categorias: Humor, Vegetativos, Motores, Sociais, Cognitivos, Ansiedade e Irritabilidade. Na interpretação do instrumento, Rafael Gonçalves apresentou **"Sintomatologia Depressiva Mínima"** totalizando **59 pontos**.

Pontos	Percentil	Classificação
59	71	Sintomatologia Depressiva Mínima

Interpretação do teste:

Rafael Gonçalves de Paulo foi submetido à EBADEP-A e obteve uma pontuação bruta total de 59 pontos, que corresponde ao percentil 71. Esse resultado sugere que Rafael Gonçalves de Paulo se encontra na categoria sintomatologia depressiva mínima. Essa categoria geralmente expressa pessoas que têm poucos sintomas em termos de frequência, duração e intensidade, não apresentando sintomas que possam causar grande sofrimento psicológico.

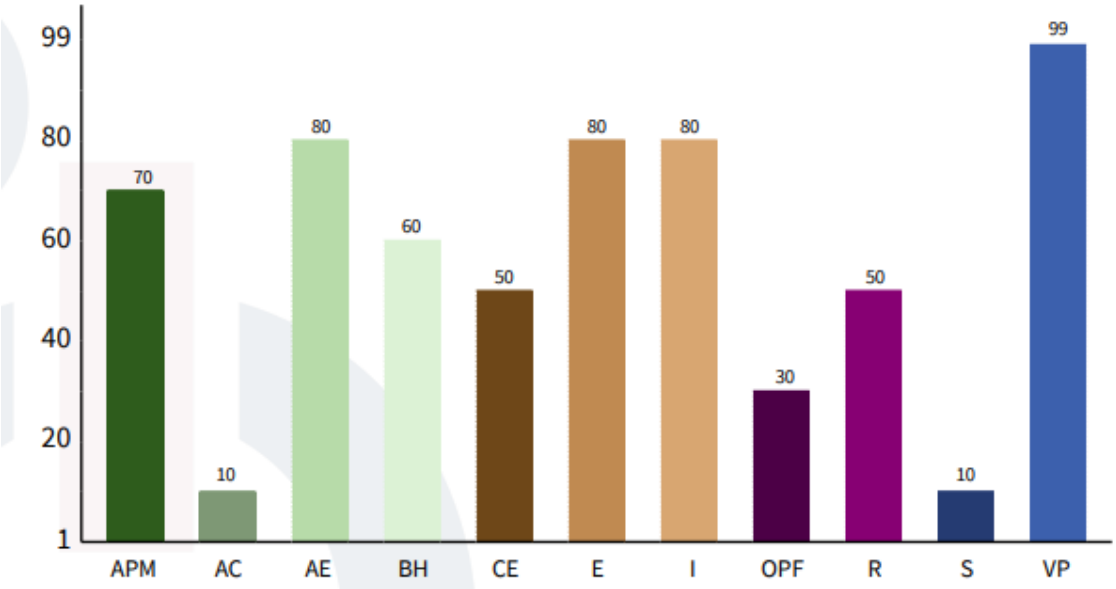
3.6 Escala dos Pilares de Resiliência - EPR

A Escala dos Pilares de Resiliência tem o objetivo de identificar, dentre as características que favorecem uma conduta resiliente, quais delas uma pessoa tem mais ou menos desenvolvidas. Verifica os atributos pessoais da resiliência que favorecem uma conduta resiliente diante das adversidades.

Resiliência pode ser definida como a capacidade dos seres humanos de superar as adversidades da vida e, além disso, saírem fortalecidos após uma situação-problema.

Resultado do EPR

ESCALAS	VALOR	PERCENTIL	CLASSIFICAÇÃO
Aceitação positiva de mudança (APM)	17	70	Alta
Autoconfiança (AC)	40	10	Muito Baixa
Autoeficácia (AE)	74	80	Alta
Bom humor (BH)	19	60	Média
Controle emocional (CE)	46	50	Média
Empatia (E)	17	80	Alta
Independência (I)	17	80	Alta
Orientação positiva para o futuro (OPF)	45	30	Baixa
Reflexão (R)	28	50	Média
Sociabilidade (S)	14	10	Muito Baixa
Valores positivos (VP)	30	99	Muito Alta



Interpretação dos Pilares mais fortes.

Aceitação positiva de mudança (APM) – Alta: Tem capacidade de se adaptar positivamente diante de situações adversas que alterem de alguma forma sua rotina, tais como perda de um emprego, doença que cause alguma sequela, mudança de

moradia para outro local ou para uma residência de menor padrão que o habitual. Reconhece que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento.

Auto eficácia (AE) – Alta: Acredita ser capaz de trazer soluções para os problemas de forma criativa e inovadora. É confiante em sua maneira de colocar os planos em prática a fim de atingir o objetivo final, além sentir-se confiante para ter iniciativa na resolução de problemas relacionados à família, ao trabalho e aos problemas pessoais.

Bom humor (BH) – Média: Na maioria das situações é capaz de lidar de forma bem-humorada, leve e otimista, podendo esporadicamente agir de forma negativa diante de uma dificuldade.

Controle emocional (CE) – Média: Na maioria das vezes demonstra controle das emoções. Eventualmente pode deixar se influenciar por sentimentos negativos podendo interferir em seus relacionamentos, mas esforça-se para contornar a situação.

Empatia (E) – Alta: Consegue perceber quando uma pessoa está triste, se está passando por algum problema, se está nervosa, etc. e é capaz de compreender as razões que a deixaram assim.

Independência (I) – Alta: É capaz de buscar seus próprios recursos sem, necessariamente, depender de outras pessoas. Embora goste de ter amigos para fazer algo, não depende deles para fazê-lo.

Reflexão (R) – Média: Nem sempre consegue entrar em contato com seus problemas e refletir sobre seus atos e consequências, podendo esporadicamente tomar decisões impensadas.

Valores positivos (VP) - Muito Alta: É uma pessoa bem-intencionada em suas ações e honesta mesmo quando seu sucesso depende do contrário, pois prefere viver com dignidade e procura estender seus princípios às pessoas de seu convívio. A classificação muito alta acentua essas características.

Interpretação dos Pilares mais fragilizados

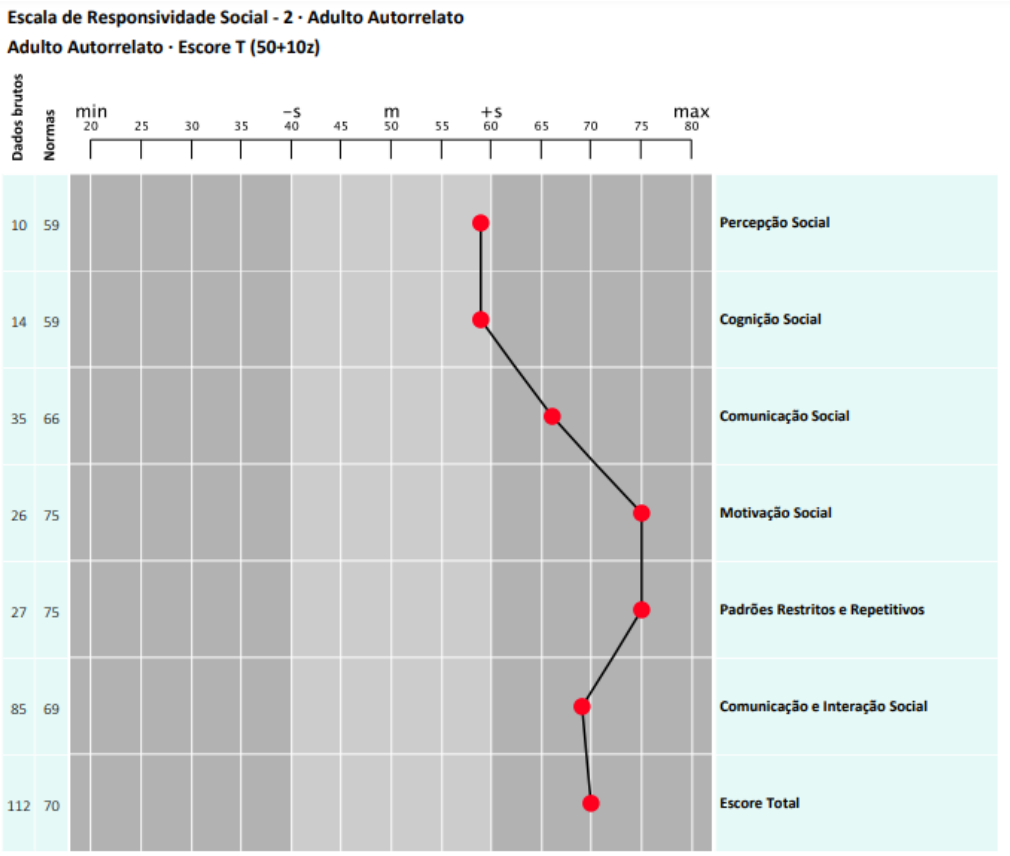
Autoconfiança (AC) - Muito Baixa: Descreveu-se com falta de iniciativa para resolver seus próprios problemas e desiste facilmente de cumprir uma tarefa quando a exigência se torna maior, além de não assumir responsabilidades por acreditar não ser capaz de cumpri-las. Demonstrou muita insegurança tanto na vida pessoal como profissional. Deixa se abater quando é criticado, pois não é seguro em relação às suas qualidades.

Orientação positiva para o futuro (OPF) – Baixa: É pessimista em relação ao futuro. Eventos negativos tendem a ser um motivo para que perca a esperança de que dias melhores virão. Não enxerga muito sentido em fazer esforços no presente para atingir um objetivo por acreditar que não trará bons resultados.

Sociabilidade (S) - Muito Baixa: É uma pessoa mais reclusa, que não busca estabelecer interações com outras pessoas, nem mesmo em caso de necessitar de ajuda. A classificação muito baixa acentua essas características.

3.7 Escala de Responsividade Social – SRS 2 – Autorrelato (Respondido pelo examinado, Rafael Gonçalves de Paulo)

A Escala de Responsividade Social, Segunda Edição (SRS-2) tem como objetivo mensurar sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a classificá-los em níveis leves, moderados ou severos. Em níveis leves e de acordo com as subcategorias especificas, é possível identificar outros transtornos, como por exemplo o Déficit Intelectual (DI), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), etc. Sua avaliação se faz de forma global e específica, já que agrupa os sintomas em subcategorias (Escalas Compatíveis ao DSM-5 e Subescalas de Intervenção). Por esse motivo, pode ser utilizada para iniciar processos diagnósticos (rastreio) e para o planejamento de intervenções clínicas e ocupacionais.



Escala de Responsividade Social - 2 · Adulto Autorrelato
Adulto Autorrelato · Escore T (50+10z)

Escala	Pontuação bruta	Valor da norma
Percepção Social	10	59
Cognição Social	14	59
Comunicação Social	35	66
Motivação Social	26	75
Padrões Restritos e Repetitivos	27	75
Comunicação e Interação Social	85	69
Escore Total	112	70

Resultado SRS-2:

O paciente apresentou escore Total de **70 – Nível Moderado.**

Interpretação SRS-2

Escore T 59 e abaixo	Dentro dos limites normais.
Escore T entre 60 e 65	Nível leve.
Escore T entre 66 e 75	Nível moderado.
Escore T entre 76 e acima	Nível severo.

No formulário de resposta foram observados os seguintes fatores:

- Fica muito mais desconfortável em situações sociais do que quando está sozinho
- Não reconhece quando os outros estão tentando tirar vantagem sobre ele
- Prefere estar sozinho do que com outras pessoas
- Reconhece quando é injusto
- Não interage apropriadamente com os outros
- Evita iniciar interações sociais
- Se pega olhando fixo para o espaço
- Tem dificuldade em responder perguntas diretamente e acaba discursando em torno do assunto
- É imaginativo
- É extremamente sensível a certos sons, texturas e cheiros

- Leva as coisas ao “pé” da letra
- É mais desconfiado do que as outras pessoas
- Tem o jeito incomum de cumprimentar as pessoas
- Tem tendência ao isolamento

4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

FUNÇÕES AVALIADAS/TESTES	CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
MEMÓRIA		
Primeiras etapas de aprendizagem (RAVLT)	Média Inferior	Defasagem
Evocação Imediata (RAVLT)	Média	Preservado
Evocação Tardia (RAVLT)	Média	Preservado
Lista de Palavras - reconhecimento (RAVLT)	Média	Preservado
Velocidade de esquecimento (RAVLT)	Média	Preservado
Interferência proativa (RAVLT)	Média	Preservado
Interferência retroativa (RAVLT)	Média Inferior	Defasagem
MEMÓRIA OPERACIONAL		
Aritmética (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
Sequência de números-letras (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
ATENÇÃO E CONCENTRAÇÃO		
Bateria Psicológica de Atenção (BPA)	Média	Preservado
Completar Figuras (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
Aritmética (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
Códigos (WAIS-III)	Média	Preservado
Raciocínio Matricial (WAIS-III)	Média	Preservado
Dígitos (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
VISUOCONSTRUÇÃO		
Códigos (WAIS-III)	Média	Preservado
Cubos (WAIS-III)	Média	Preservado
LINGUAGEM E FLUÊNCIA VERBAL		
Semelhanças (WAIS-III)	Média	Preservado
Vocabulário (WAIS-III)	Média Inferior	Defasagem
Informação (WAIS-III)	Média	Preservado
Compreensão (WAIS-III)	Média	Preservado

5. CONCLUSÃO

Rafael Gonçalves apresentou coeficiente intelectual global “Médio” (QI:98) de acordo com sua faixa etária. Ficou evidente a preservação de fatores associados com a velocidade de processamento, organização perceptual, memória operacional, raciocínio logico, raciocínio sequencial, reflexão verbal e pensamento abstrato.

Os testes indicam que, Rafael, dispõe de atenção concentrada bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para selecionar uma única fonte de informação diante de vários estímulos distratores em um tempo predeterminado. Rafael dispõe de atenção dividida bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para procurar dois ou mais estímulos simultaneamente em um tempo predeterminado, e com vários distratores ao redor.

O paciente tem a atenção alternada bem acima da média, se comparado às pessoas da amostra normativa, o que indica bastante facilidade para focar sua atenção e selecionar ora um estímulo, ora outro, por um determinado período de tempo e diante de vários estímulos distratores.

O paciente se descreveu-se com falta de iniciativa para resolver seus próprios problemas e desiste facilmente de cumprir uma tarefa quando a exigência se torna maior, além de não assumir responsabilidades por acreditar não ser capaz de cumpri-las. Demonstrou muita insegurança tanto na vida pessoal como profissional. Deixa se abater quando é criticado, pois não é seguro em relação às suas qualidades. É pessimista em relação ao futuro. Eventos negativos tendem a ser um motivo para que perca a esperança de que dias melhores virão. Não enxerga muito sentido em fazer esforços no presente para atingir um objetivo por acreditar que não trará bons resultados.

Rafael é uma pessoa mais reclusa, que não busca estabelecer interações com outras pessoas, nem mesmo em caso de necessitar de ajuda. A classificação muito baixa acentua essas características.

No teste SRS 2, o paciente apresentou os seguintes comportamentos: Fica muito mais desconfortável em situações sociais do que quando está sozinho, não reconhece quando os outros estão tentando tirar vantagem sobre ele, prefere estar sozinho do que com outras pessoas, reconhece quando é injusto, não interage apropriadamente com os outros, evita iniciar interações sociais, se pega olhando fixo para o espaço, tem dificuldade em responder perguntas diretamente e acaba discursando em torno do assunto, é imaginativo, é extremamente sensível a certos sons, texturas e cheiros, leva as coisas ao "pé" da letra, é mais desconfiado do que as outras pessoas, tem o jeito incomum de cumprimentar as pessoas e tem tendência ao isolamento.

Além disso, conforme coleta de informações, por meio de um questionário sobre a infância do paciente, a mãe de Rafael relata que ele tinha sensibilidade a sons, texturas e cheiros, caminhava na ponta dos pés, tinha apego exagerado a determinados objetos, não gostava de sair da rotina, ficava tenso em situações sociais, tinha dificuldade em fazer amigos, ficava tensa em situações sociais e preferia ficar sozinho do que com outras pessoas.

Na avaliação quantitativa no BPA (Bateria Psicológica de Atenção) o paciente apresenta resultados preservados, porem precisamos levar em consideração que o consultório aonde é feito a aplicação é extremamente controlado, sem ruídos e sem estímulos distratores, sendo possível resultados melhores na manutenção do foco, atenção e concentração. Olhando para as queixas colhidas durante a análise e toda análise qualitativa dos sintomas do paciente, como por exemplo a procrastinação, dificuldade para persistir em seus objetivos, tendência a começar várias atividades e não finaliza-las, ter dificuldade para dormir (o sono não é reparador), a desmotivação, perca de interesses pelas atividades, pensamentos desorganizados (preocupação com pequenas coisas do dia a dia), as oscilações de humor e a desorganização, é possível identificar um quadro de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Baseado no histórico de vida do paciente, nas análises durante a avaliação, nos testes psicológicos e neuropsicológicos e no CID-11, conclui-se que, Rafael Gonçalves de

Paulo, apresenta alterações do neurodesenvolvimento que configuram diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Apresentação Predominantemente Desatento (6A05.0) e Transtorno do Espectro Autista (6A02).

Tais observações são pautadas por critérios diagnósticos do Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM V.

Sendo assim, é sugerido a manutenção do acompanhamento com Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e a manutenção do acompanhamento com o Médico Psiquiatra.

Este documento possui 21 (vinte e um) laudas numeradas e a última página assinada digitalmente pela Neuropsicóloga Thuanne de Castro Martins Lima.

Necessária reavaliação para verificar a evolução do paciente diante das orientações realizadas.

Para mais informações, encontro-me à disposição.

Brasília, 23 de maio de 2023.
Neuropsicóloga: Thuanne de Castro
CRP: 01/24215

THUANNE DE CASTRO MARTINS LIMA:06079774186

Assinado de forma digital por THUANNE DE CASTRO MARTINS LIMA:06079774186
Dados: 2023.05.23 09:25:30 -03'00'